

101 ✓✓✓	骨粗鬆症
102 ✓✓✓	糖尿病
103 ✓✓✓	胸鎖乳突筋の肥厚
104~110 ★★★	COPD の胸部レントゲン所見として認められやすいものはどれか。
104 ✓✓✓	肺野透過性の減弱
105 ✓✓✓	肺野末梢の血管陰影の細小化
106 ✓✓✓	肋間の拡大
107 ✓✓✓	横隔膜の挙上
108 ✓✓✓	心胸郭比の減少
109 ✓✓✓	側面像で、胸骨後腔の拡大
110 ✓✓✓	側面像で、心臓後腔の拡大
111~117 ★★★	COPD の胸部 CT 所見として、適切なものはどれか。
111 ✓✓✓	ウィンドウレベルは-700HU~-900HU 程度に設定することが多い。
112 ✓✓✓	ソフトウェアによる気腫の定量的解析では、-940HU~-960HU 以下を低吸収領域 (low attenuation area: LAA) と設定することが多い。
113 ✓✓✓	古典的な肺気腫の視覚評価法として Goddard 分類がある。